Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

2.5 Жалобы и анамнез 6

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Физикальное обследование и консультации специалистов 7

3.3 Лабораторные исследования 7

3.4 Инструментальные исследования 7

4. Лечение 7

4.1 Базовая терапия 8

4.2 Системная антибактериальная терапия 8

4.3 Местная антибактериальная терапия 9

4.4 Дополнительная терапия 9

4.5 Хирургическое лечение 10

4.6 Иное лечение 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Послеоперационное ведение 11
5.2 Профилактика 11
5.3 Показания к госпитализации 12
5.4 Прогноз 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Диагноз хронического синусита у взрослых устанавливается при наличии двух и более симптомов на протяжении 12 недель и более, одним из которых является заложенность носа или выделения из носа; диагноз подтверждается эндоскопическими признаками или изменениями по данным компьютерной томографии (КТ).
- Основой консервативного лечения являются промывание полости носа солевым раствором, показанное всем пациентам, и интраназальные глюкокортикостероиды с 12 лет; для оценки эффекта глюкокортикостероидов длительность их применения должна составлять не менее 3 месяцев.
- К системной антибактериальной терапии прибегают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовым препаратом в амбулаторной практике является амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым при неэффективности 1–2 курсов адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия.
- При случайном выявлении бессимптомной кисты околоносовой пазухи большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку многие кисты медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
- Мукоцеле характеризуется медленным ростом, растягивает, а в ряде случаев разрушает стенку пазухи, поэтому его во всех случаях удаляют хирургически.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) характеризуется воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух длительностью более 12 недель, сопровождающимся двумя и более симптомами. Одним из них является заложенность носа или выделения из носа (передние или стекающие в носоглотку); к нему могут присоединяться боль или ощущение давления в области лица, снижение или потеря обоняния.

Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты околоносовых пазух образуются в результате закупорки выводных протоков желёз слизистой оболочки; их стенки имеют двустороннюю выстилку мерцательным цилиндрическим эпителием. Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты располагаются в толще слизистой оболочки, не имеют внутренней эпителиальной выстилки и возникают вследствие хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле представляет собой доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование околоносовой пазухи. Оно формируется при стойком нарушении дренажной функции естественного соустья пазухи и часто вызывает растяжение, реже разрушение её стенок.

2.2 Этиология

С развитием ХРС ассоциированы аллергический ринит, первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), иммунодефицитные состояния и системные аутоиммунные заболевания.

Важным фактором риска являются анатомические особенности в области остиомеатального комплекса: искривление перегородки носа, буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина, гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки, аномалии крючковидного отростка, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи. Эти особенности нарушают вентиляцию полости носа и отток секрета из полости носа и околоносовых пазух. У детей, значительно реже у взрослых, ХРС может быть связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольного возраста, основной причиной ХРС является муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По данным отечественных исследований, связь между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не выявлена.

Предрасполагающим фактором может являться также аллергический отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с заболеваниями зубов и стоматологическим лечением. Хронический верхнечелюстной синусит может быть осложнением периодонтита или пародонтита; частой причиной является эндодонтическое лечение, при котором инфицированный детрит или пломбировочный материал попадает в пазуху через корневые каналы. Причиной воспаления в пазухе может быть также дентальная имплантация с предшествующим наращиванием костной ткани. При одонтогенном синусите среди возбудителей преобладают анаэробы.

ГЭРБ также может способствовать развитию ХРС: попадание рефлюктата на слизистую оболочку полости носа и носоглотки вызывает воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса, что может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важным фактором риска является курение: табак оказывает токсическое действие на слизистую оболочку полости носа, вызывает её сухость и изменяет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалительными заболеваниями полости носа и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты в большинстве случаев обусловлены хроническим, прежде всего аллергическим, воспалением слизистой оболочки; риск их развития повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста развивается из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба; зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё; фолликулярная киста развивается очень медленно из зубного фолликула.

Мукоцеле в подавляющем большинстве случаев является следствием операций на околоносовых пазухах; к другим причинам относятся травма, хроническое воспаление пазух, опухоли и лучевая терапия. Более чем в трети случаев причину установить не удаётся; описаны также врождённые мукоцеле. У детей мукоцеле чаще всего развивается вследствие вторичного хронического синусита при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации, с указанием стороны поражения, выделяют верхнечелюстной, этмоидальный, фронтальный и сфеноидальный синусит. Воспаление пазух только одной стороны обозначается как гемисинусит, поражение нескольких пазух как полисинусит.

В клинической практике хронический синусит принято подразделять на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По этиологии выделяют бактериальный, грибковый и бактериально-грибковый синусит.

Тяжесть течения оценивается по суммарной выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10: выделяют лёгкую (0–3 балла), среднетяжёлую (4–7 баллов) и тяжёлую (8–10 баллов) форму.

> Классификация по тяжести содержит ссылку на приложение Г1, однако в нём описана ВАШ только для оценки интенсивности боли и с другой градацией: значение до 2 см соответствует слабой боли, 2–4 умеренной, 4–6 сильной, 6–8 сильнейшей, до 10 невыносимой. Способ подсчёта суммарной выраженности симптомов в рекомендации не указан.

Классификация EPOS 2020 года основана на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит может быть односторонним (локализованным), с воспалением 2-го типа или не 2-го типа (сюда же относят аллергический грибковый синусит и изолированный синусит одной пазухи), и двусторонним (диффузным) с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний синусит может быть механическим, воспалительным и иммунным; к его фенотипам относятся первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

В России кисты околоносовых пазух, как правило, классифицируются по М. И. Кадымовой: выделяют ретенционные, лимфоэктатические, одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи и кисты, связанные с пороками развития.

Более 90% кист локализуются в верхнечелюстной пазухе, около 5% в клиновидной пазухе, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта кисты встречаются крайне редко. Более чем в 80% случаев киста односторонняя; множественные кисты выявляются лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; ряд авторов считает наиболее частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны также крайне редкие локализации: нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина ХРС неспецифична: заложенность носа, выделения из носа и стекание по задней стенке глотки, головная или лицевая боль, снижение или отсутствие обоняния, ощущение неприятного запаха в носу. Основными симптомами, в наибольшей степени влияющими на самочувствие пациента, являются заложенность носа и выделения. У детей ключевым симптомом может быть также кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки. Хронический синусит отличается от острого сохранением симптомов более 12 недель без полного их разрешения.

Кисты околоносовых пазух часто протекают бессимптомно и выявляются случайно при лучевом исследовании головы. Крупная киста чаще всего вызывает головную или лицевую боль, редко внезапное истечение из носа жидкости янтарного цвета при самопроизвольном разрыве кисты, онемение верхней губы или зубную боль. Заложенность носа, выделения и кашель вследствие стекания слизи у пациента с кистой, вероятнее всего, обусловлены сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Клинические проявления мукоцеле зависят от его локализации и размера. Основными симптомами являются головная боль, ощущение давления в области лица, заложенность носа, выделения из носа, боль в периорбитальной области. Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, однако значительно реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Взрослые пациенты предъявляют жалобы на стойкую одностороннюю или попеременную заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, необходимость сморкания или стекание слизи по задней стенке глотки (более выраженное после пробуждения или постоянное в течение дня), неприятный запах в полости носа или носоглотке, снижение обоняния вплоть до аносмии. При хроническом сфеноидите отмечается периодическая боль в теменной и затылочной областях.

Для хронического фронтита характерна выраженная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Возможно ощущение давления за спинкой носа и глазными яблоками, усиливающееся при обострении.

У детей младшего возраста жалобы выясняются у родителей или опекунов: частые затяжные «насморки», заложенность носа, слизистые выделения, кашель, преимущественно ночью или в положении лёжа на спине.

При выявлении кистоподобного образования по данным лучевых исследований в первую очередь уточняется наличие головной или лицевой боли, её постоянный характер, провоцирующие и усиливающие её факторы. Выясняются перенесённые ранее операции на полости носа и околоносовых пазухах и стоматологическое лечение.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У взрослых диагноз хронического синусита устанавливается при наличии двух и более симптомов на протяжении 12 недель и более, одним из которых является заложенность носа, затруднение носового дыхания или выделения из носа (передние или стекающие по задней стенке глотки); к ним могут присоединяться боль или ощущение распирания в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Диагноз подтверждается эндоскопическими признаками (полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе) и изменениями слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух по данным КТ.

У детей для постановки диагноза необходимы два и более из четырёх симптомов на протяжении 12 недель и более: затруднение носового дыхания, боль или ощущение распирания в проекции пазух, выделения из носа или стекание по задней стенке глотки, кашель. Эндоскопические признаки и изменения по данным КТ аналогичны таковым у взрослых.

Диагноз кисты околоносовой пазухи устанавливается по данным КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ): округлое однородное мягкотканное образование на широком основании с чёткими границами, без деструкции кости и выраженной деформации стенок. Дифференцировать ретенционную и лимфоэктатическую кисту возможно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Диагноз одонтогенной кисты верхнечелюстной пазухи устанавливается по данным КТ (однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи с чёткими границами, оболочкой костной плотности и связью с корнями верхних зубов) с учётом заключения стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о заболевании соседних зубов.

Диагноз мукоцеле устанавливается по данным КТ: образование в пазухе с округлым ровным контуром и однородным содержимым без кальцинатов и включений; возможны истончение прилежащих костных структур и пролабирование образования в соседние анатомические области.

3.2 Физикальное обследование и консультации специалистов

Всем пациентам с хроническим синуситом, а также с подозрением на кисту или мукоцеле необходим осмотр оториноларинголога с оценкой общего состояния, сбором жалоб и анамнеза, планированием лечения.

При отягощённом аллергологическом анамнезе необходима консультация аллерголога пациентам с хроническим синуситом, а взрослым также при подозрении на кисту или мукоцеле.

При симптомах рефлюкса рекомендуется консультация гастроэнтеролога.

При признаках муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии необходима консультация генетика.

При подозрении на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи пациента направляют к стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу для подтверждения или исключения одонтогенной причины.

3.3 Лабораторные исследования

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также при обострении выполняют бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности для выбора или коррекции антибактериальной терапии.

Оптимальным материалом для исследования является аспират непосредственно из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или интраоперационно.

3.4 Инструментальные исследования

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки выполняют всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом для оценки состояния синоназальных структур и подтверждения диагноза.

Спиральную КТ околоносовых пазух применяют при признаках осложнений во время обострения, перед хирургическим вмешательством и при необходимости дифференциальной диагностики.

КТ является наиболее информативным методом как у взрослых, так и у детей. Метод позволяет выявить изолированное воспаление, блок соустья, инородное тело, диффузный грибковый процесс или мицетому, опухоль, аномалии развития пазух, заподозрить одонтогенную причину. Типичными признаками ХРС являются утолщение слизистой оболочки и снижение пневматизации в области соустий.
Для планирования объёма операции КТ выполняется не ранее чем за 6 месяцев до вмешательства.

Спиральная КТ околоносовых пазух необходима всем пациентам с подозрением на кисту, выявленную другим методом и сопровождающуюся постоянными или периодическими симптомами, а также всем пациентам с подозрением на мукоцеле.

При затруднении дифференциальной диагностики мукоцеле с другими образованиями КТ выполняется с внутривенным болюсным контрастированием: контрастное вещество накапливается в оболочке мукоцеле, но не в его содержимом.

---

4. Лечение

Этиологических факторов ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирается каждому пациенту индивидуально.

Основой консервативного лечения является медикаментозная терапия; по показаниям она может назначаться и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательства эффективности консервативного лечения кист и мукоцеле околоносовых пазух отсутствуют; уменьшение симптомов возможно лишь при эффективности медикаментозной терапии сопутствующего ХРС или аллергического ринита.

4.1 Базовая терапия

Всем пациентам с ХРС рекомендуется промывание полости носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором, что обеспечивает очищение полости носа и уменьшает антигенную нагрузку на слизистую оболочку.

Промывание полости носа имеет важное значение и в составе послеоперационного лечения.

Пациентам старше 12 лет для уменьшения выраженности симптомов применяют интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС).

Единая схема дозирования, кратности и длительности применения отсутствует; допустимо применение как низких, так и высоких доз. Для оценки эффекта лечение продолжается не менее 3 месяцев.

Носовые кровотечения вследствие сухости слизистой оболочки чаще отмечаются при применении высоких доз. Официально зарегистрированное показание при хроническом риносинусите имеется только у назального спрея мометазона: взрослым и детям старше 12 лет по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, что составляет 400 мкг в сутки.

4.2 Системная антибактериальная терапия

Системную антибактериальную терапию назначают при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с заболеваниями, повышающими риск бактериальной инфекции.

Препарат	Показания и режим дозирования
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой тела менее 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензия 400/57 мг в 5 мл назначается по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. Пациентам с массой тела более 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг — 8 мг/кг в сутки в 1 приём; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в сутки.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	При неэффективности амоксициллина с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой тела от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки в 1 приём, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки в 1 введение, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым пациентам в амбулаторных условиях при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курс 10–14 дней. Знак # обозначает применение вне инструкции.

Лечение детей с обострением, требующим системной антибактериальной терапии, при невозможности назначения пенициллинов предпочтительно проводить в условиях стационара; препарат выбирается с учётом тяжести, локализации и распространённости воспаления и чувствительности выделенного возбудителя.

При неэффективности стартового антибиотика в амбулаторных условиях следует решить вопрос о направлении пациента в оториноларингологическое отделение стационара в неотложном порядке. В стационаре при среднетяжёлом течении предпочтителен пероральный приём препаратов, при его невозможности парентеральное введение; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводятся внутривенно.

При неэффективности цефалоспоринов III поколения или выделении устойчивых к ним штаммов переходят на препарат резерва (цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие) с учётом чувствительности возбудителя.

Эффект антибактериальной терапии должен проявиться на третьи сутки; при наличии эффекта препарат применяется в течение 10–14 дней.

4.3 Местная антибактериальная терапия

При лёгком обострении у пациентов, ранее перенёсших синусотомию, при появлении гнойных выделений используют местные антибактериальные препараты.

Эффект оценивается через 3–4 дня; при его отсутствии решается вопрос о системной антибактериальной терапии. В России для лечения ХРС зарегистрированы назальный спрей фрамицетина (для детей с первых лет жизни) и комбинированный спрей, содержащий дексаметазон, неомицин, полимиксин B и фенилэфрин (с 2,5 лет). Разовая и суточная дозы должны строго соответствовать инструкции. При обострении фрамицетин применяется не более 7 дней, комбинированный препарат не более 10 дней.
Введение в полость носа и околоносовые пазухи растворов антибиотиков, предназначенных для внутримышечного и внутривенного введения, не допускается: они не адаптированы для этой цели и оказывают повреждающее действие на мерцательный эпителий. Для введения в пазуху может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Дополнительная терапия

При обострении и отсутствии противопоказаний для более быстрого регресса симптомов рекомендованы растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием.

Эффективны комбинированные препараты, содержащие экстракты корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.

При обострении для облегчения оттока секрета из пазух применяют сосудосуживающие капли или спреи в нос.

Нафазолин обладает выраженным токсическим действием, и его применение в оториноларингологической практике не допускается. Предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%. Препараты применяются строго по назначению и под контролем врача, не более 5–7 дней, поскольку более длительное применение приводит к развитию медикаментозного ринита.

Муколитические препараты используют для разжижения отделяемого и облегчения его оттока.

Карбоцистеин назначается коротким курсом, до 2–3 недель, при обострении с густым секретом в полости носа; возможны также курсы продолжительностью около 3 месяцев в сочетании с противовоспалительными средствами. Одновременное назначение карбоцистеина с другими отхаркивающими и муколитическими средствами, в том числе местными, не рекомендуется, поскольку при этом усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

При повышении температуры тела, головной или лицевой боли в период обострения рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол.

Детям до 6 лет допустимо применение только парацетамола (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофена (до 30 мг/кг в сутки).

4.5 Хирургическое лечение

При тяжёлом обострении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, оперируют в неотложном или экстренном порядке. При среднетяжёлом обострении и неэффективности консервативного лечения возможно проведение малоинвазивных манипуляций в неотложном порядке. Остальным пациентам хирургическое лечение выполняют в плановом порядке по показаниям; при отсутствии показаний или наличии противопоказаний ограничиваются консервативным лечением и наблюдением оториноларинголога.

Под функциональной риносинус-хирургией в рекомендации понимаются фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, гайморотомия и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых при наличии соответствующего оснащения предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановом вмешательстве она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют в плановом порядке, как правило, теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи в ряде случаев используются микрогайморотомия и фронтотомия через переднюю стенку.

При тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, а при среднетяжёлом в случае неэффективности консервативного лечения показана пункция пазухи для её дренирования.

Через пункционную иглу промывают пазуху раствором антисептика, удаляют секрет и вводят антибиотик.

Пункция допустима только при наличии результатов лучевого исследования, исключающих гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и подтверждающих скопление в ней секрета.

При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию выполняют только в условиях стационара.

Для дренирования возможны установка синус-катетера или зондирование пазух через естественные соустья.

Взрослым при неэффективности 1–2 курсов адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия для восстановления аэрации пазух, устранения симптомов и предотвращения осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение: в рекомендации о хирургическом лечении взрослых показанием является неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, тогда как в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Детям с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени при неэффективности консервативного лечения в течение 3–6 месяцев первым этапом удаляют аденоиды.

Вмешательство планируют при отсутствии противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в условиях оториноларингологического отделения или стационара кратковременного пребывания; при наличии соответствующего оснащения вмешательство проводится под эндоскопическим контролем.

Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС при неэффективности лечения в течение 3–6 месяцев, если гипертрофия аденоидов исключена или удаление аденоидов выполнено более 6 месяцев назад, показана функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.

Операция плановая. Вмешательство не нарушает рост пазух и лицевого скелета, однако у детей выше риск рубцевания и повторного стенозирования, а малые размеры анатомических структур требуют современного оборудования.

Детям с изолированным поражением пазухи выполняют эндоскопическое дренирование пазухи.

Операцию выполняют независимо от состояния аденоидов при наличии на КТ отграниченного тотального или субтотального затемнения одной пазухи или резкого снижения её пневматизации в сочетании с типичными жалобами. У детей необходима онкологическая настороженность в отношении любого образования, выявленного по данным КТ, за исключением кист с чёткими типичными признаками, не увеличивающихся в размерах.

Киста околоносовой пазухи, сопровождающаяся постоянными или периодическими симптомами, подлежит эндоскопическому удалению с опорожнением кисты и полным или частичным удалением её оболочки.

При случайном выявлении бессимптомной кисты большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку кисты, за исключением одонтогенных, часто медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.

Мукоцеле у всех пациентов дренируют эндоскопически.

При лобной локализации методом выбора считается эндоскопическая марсупиализация с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении мукоцеле, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле с распространением в полость черепа используется наружный доступ.

4.6 Иное лечение

Пациенты с вторичным ХРС, у которых изменения в полости носа и околоносовых пазухах являются проявлением другого заболевания, находятся под наблюдением и получают лечение у профильного специалиста. Лечение одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи осуществляют совместно со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Послеоперационное ведение

После операции все пациенты находятся под амбулаторным наблюдением оториноларинголога для оценки состояния полости носа и своевременного выявления поздних осложнений.

Первый осмотр проводится через 7–14 дней после выписки, далее повторно несколько раз в течение года для контроля течения заболевания и своевременной коррекции лечения. Осмотры необходимы для контроля состояния полости носа (при неадекватном уходе образуются корки и синехии), выявления и предупреждения осложнений, а также для выполнения манипуляций при необходимости.

В течение месяца после операции пациенту необходимо соблюдать щадящий режим и избегать факторов, повышающих давление и способных спровоцировать кровотечение: интенсивных физических нагрузок, перегревания и переохлаждения. Для профилактики острой респираторной инфекции рекомендуется избегать мест массового скопления людей и по возможности больше времени проводить дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика направлена на защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, вторичная на максимально раннее выявление заболевания. Профилактике хронического синусита способствуют своевременное лечение заболеваний зубов и гастроэзофагеального рефлюкса, отказ от курения и соблюдение техники безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Профилактикой мукоцеле является соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на полости носа и околоносовых пазухах, профилактикой лимфоэктатических кист своевременное лечение хронического воспаления в полости носа, радикулярных кист своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту разъясняется, что полное излечение хронического синусита затруднительно, однако выраженность симптомов может быть уменьшена; как правило, требуется пожизненный контроль, а тактику лечения определяет оториноларинголог, в ряде случаев совместно с другими специалистами.

Важное значение имеет изменение образа жизни: отказ от курения или по крайней мере уменьшение количества выкуриваемых сигарет, а при аллергии соблюдение гипоаллергенного быта. Необходимы также приверженность лечению, соблюдение режима дозирования, правильная техника введения препаратов и промывания полости носа.

5.3 Показания к госпитализации

Лечение пациентов с хроническим синуситом, кистами и мукоцеле осуществляет прежде всего оториноларинголог, при необходимости совместно с аллергологом-иммунологом, гастроэнтерологом, ревматологом, стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом. Консервативное лечение и лечение лёгких обострений осуществляются в амбулаторных условиях.

Показаниями к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение являются внутричерепные или внутриглазничные осложнения, тяжёлое обострение, а также среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения в течение 5–7 дней или прогрессирующем ухудшении состояния в любые сроки.

Показаниями к плановой госпитализации для хирургического лечения являются подтверждённый хронический синусит, резистентный к адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев; рецидив симптомов после операции; сохранение жалоб и признаков синусита у детей после удаления аденоидов; изолированное воспаление с субтотальным или тотальным снижением пневматизации по данным КТ на протяжении более 2 месяцев; подозрение на новообразование пазухи неясного характера; «синдром молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи по данным КТ; киста с постоянными или периодическими симптомами и мукоцеле.

Пациент выписывается после выполнения операции в запланированном объёме при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии местного или системного острого инфекционно-воспалительного процесса.

5.4 Прогноз

Эффективность лечения зависит от индивидуальных анатомических особенностей полости носа и околоносовых пазух, наличия хронических системных заболеваний, активного и пассивного курения, профессиональных вредностей, климатических и экологических условий, а также от приверженности пациента лечению.

Одонтогенные кисты не регрессируют самостоятельно, и их лечением совместно занимаются несколько специалистов.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки хирургического лечения у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии операция показана после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации (раздел 6) после 6 месяцев неэффективной терапии.
- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, в котором описана ВАШ только для оценки боли и с другой градацией.
- В определении указана длительность симптомов «более 12 недель», в критериях диагноза «12 недель и более» (≥12 недель).

- Удаление аденоидов в рекомендации обозначено как «аденоидэктомия», в комментарии к ней как «аденотомия».
- В комментарии об антибактериальной терапии у детей повторяется оборот «в случае невозможности применения при невозможности применения».
- В оглавлении разделы «Хирургическое лечение» и «Иное лечение» пронумерованы как «3.» вместо 3.2 и 3.3.